

x 250 mm

**FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE**

Tipo de dispositivo: Lente Intraocular (Afáquica)

Introducción

La catarata es una afección que se vuelve más frecuente con la edad. Una catarata se desarrolla con el tiempo a medida que el cristalino natural del ojo se endurece y se vuelve gradualmente opaco. Las personas con cataratas experimentan una visión "nublada". Los colores se vuelven menos vivos con el tiempo y suele haber una mayor sensibilidad a la luz. Por ejemplo, una persona con cataratas probablemente experimentará un mayor deslumbramiento causado por los faros de los vehículos que se aproximan durante la noche. Sin tratamiento, la catarata acabará bloqueando el paso de la luz a través del ojo y provocará ceguera.

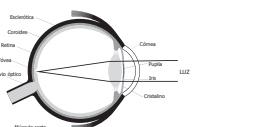


Fig. 1: Anatomía del ojo

¿Cómo afecta la catarata a su visión?
La catarata afecta al cristalino natural del

sobre la parte posterior del ojo (la retina) para que podamos ver con claridad. El cristalino es flexible y cambia de forma para enfocar a enfocar objetos tanto cercanos como lejanos. Cuando observamos algo cercano, el cristalino se curva; cuando observamos algo lejano, se aplanan. Esta capacidad del cristalino para ajustarse a diferentes distancias se denomina "acomodación". A medida que envejecemos, el cristalino se vuelve menos flexible, lo que dificulta enfocar objetos cercanos; esta condición se denomina presbicia y puede dificultar la lectura de textos con letra pequeña. La catarata añade otro problema: el cristalino, que normalmente es transparente, se vuelve gradualmente opaco. Esto provoca una visión borrosa con el tiempo. Cuando las cataratas comienzan a afectar la visión, es necesario extraer el cristalino natural opaco y reemplazarlo por una lente artificial mediante cirugía.

.....

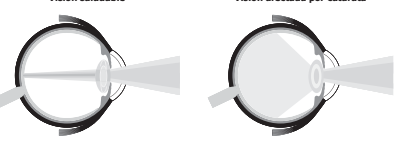


Fig. 2: Simulación de la visión sin y con cataratas

¿Qué es una Lente Intraocular (LIO)?

Se han producido importantes avances en los materiales y diseños de las lentes intraoculares. Ofrecemos lentes intraoculares de diferentes tipos de materiales, incluidos: polimetilmetacrilato (PMMA), materiales acrílicos como el acrílico hidrofóbico (repelente al agua) y el acrílico hidrofílico (absorbente de agua).

2



Fig. 3: Imagen representativa de una lente intraocular artificial

Diferentes tipos y rendimiento de las LIO

Las opciones de tratamiento distintas de una nueva lente permanente incluyen gafas con lentes gruesas y lentes de contacto. Comente con su oftalmólogo los posibles riesgos y beneficios de las distintas opciones de tratamiento.

- **L10 Monofocales**

Las L10 monofocales restauran una visión clara a distancia. Esto significa que debería ver bien cuando asista a un evento deportivo o la señales lejanas. Probablemente necesitará gafas para tareas de visión cercana, como leer un libro, escribir o realizar manualidades. También puede necesitar gafas para actividades de visión intermedia, como trabajar con un ordenador, maquiarse o afeitarse.
- **L10 Multifocales**

Todas las L10 están generalmente diseñadas para la visión de lejos. Sin embargo, las L10 multifocales también están diseñadas para mejorar la visión cercana e intermedia en comparación con la visión de lejos. Esto significa que debería ver bien tanto cuando asista a un evento deportivo como cuando lea un libro. Las lentes multifocales tienen diferentes potencias para la visión cercana, según las necesidades de su estilo de vida. En general, es posible que necesite usar gafas con menos frecuencia para las tareas dieras. Sin embargo, la nitidez de su visión también puede depender en comparación con una lente monofocal. Esto ocurre especialmente en condiciones de baja visibilidad, como luz tenue o niebla. También puede notar más halos (anillos alrededor de las luces) o deslumbramientos (luz reflejada que dificulta la visión). Ambos fenómenos son comunes con las L10 multifocales.
- **L10 EDOF (Profundidad de Enfoque Extendida)**

Permiten una visión nítida desde distancias lejanas hasta intermedias, como la distancia de una pantalla de ordenador. Para actividades de cerca, como leer letra pequeña o realizar trabajos de precisión, los pacientes implantados con lentes EDOF pueden necesitar gafas de lectura. Sin embargo, experimentar menos alteraciones visuales durante la noche, ya que a veces son causadas por fuentes de luz intensa en las L10 multifocales. Por ello, las lentes EDOF representan una combinación atractiva de mayor independencia de las gafas que las L10 monofocales y menos efectos secundarios potenciales que las L10 multifocales.
- **L10 Tóricas**

Las L10 Tóricas restauran una visión clara a distancia en pacientes con astigmatismo. El astigmatismo es una visión borrosa o distorsionada causada por una córnea de forma irregular. Si tiene astigmatismo, una L10 tórica puede ser la elección adecuada para usted.
- **L10 Tóricas Multifocales**

Las lentes intraculares tóricas multifocales están diseñadas para corregir el astigmatismo y, al mismo tiempo, mejorar la visión a múltiples distancias, incluidas la lejano, la intermedia y la cercana. Esto puede permitirle realizar muchas actividades cotidianas, como leer, utilizar un ordenador o ver objetos cercanos, reduciendo la dependencia de las gafas.

cercana. Esto puede permitirle realizar muchas
ordenador o ver objetos distantes, reduciendo la c

Qué esperar antes de la cirugía de cataratas

Será evaluado antes de la cirugía. Esto incluye la comprobación de posibles enfermedades oculares y la medición de su ojo para determinar la potencia correcta de la lente. Si utiliza lentes de contacto, su oftalmólogo puede pedirle que deje de usarlas antes de realizar las pruebas. Informe a su oftalmólogo si padece alguna afección médica que pueda afectar a la cirugía o a su visión.

Algunos ejemplos son la hipertensión arterial. Proporcione a su oftalmólogo una lista actualizada

Qué esperar durante la cirugía de cataratas

La cirugía de cataratas suele realizarse como un procedimiento ambulatorio. Se le administrará anestesia en forma de gotas oftálmicas para adormecer el ojo. Normalmente permanecerá completamente despierto durante la cirugía. Puede esperar sentir poca o ninguna molestia. Su oftalmólogo utilizará un microscopio para obtener una visión ampliada de su ojo. Su cristalino natural se encuentra dentro de una estructura similar a una bolsa denominada cápsula del cristalino. La cápsula del cristalino está situada justo detrás de la parte coloreada del ojo (la iris). Se realiza una pequeña incisión en la superficie externa del ojo. El oftalmólogo introduce el ojo nuevo.

en

What to expect after cataract surgery

Right after surgery, you should stay in the recovery area for a short time. Your eye doctor should give you an identification card (typically called implant card) to keep in your wallet. This card shows the type of implant in your eye. Present this card to any eye doctor who examines your eyes after surgery.

Many patients may begin to see better within 1 to 2 days. Some are stable at 10 to 14 days. Some may take 4 to 6 weeks to recover from surgery. Improvements in vision are different for each person.

Call your eye doctor right away if you experience any itching, pain, flashing lights, "floaters", redness, severe headache, nausea/vomiting, light sensitivity, or watery eyes after surgery.

Instructions for post-operative care

You will be allowed to return home on the same day after surgery. Your eye doctor will give you antibiotic eye drops and medicines to speed up healing and to prevent infection. Take all prescribed medicines and apply eye drops as instructed by your eye doctor.

For the first week after surgery, do not go swimming or use a bath or hot tub to help prevent infection. Also try to protect your eye from things like dirt, dust, and strong wind. Keep the eyes protected with sunglasses as much as possible and sleep with your eye shield at night. You should avoid rubbing your eye or putting extra pressure on it. You will be given a date and time for a follow-up visit. It is typically the next day. Your doctor will examine you several more times following your surgery depending on the speed of healing. It may take you some time to get used to new IOL.

Talk to your eye doctor if you have any questions or concerns after surgery.

Undesirable side effects, warnings and residual risk

Visual light phenomena

After cataract surgery, some patients may notice glare or halos, especially in low light. Halos appear as bright rings around lights, while glare is bright light that can affect clear vision. These effects may be more noticeable when driving at night or looking at artificial lights.

In most cases, these effects improve within a few weeks or months as the brain adapts to the intraocular lens. If they continue after healing, consult your ophthalmologist. Always follow your surgeon's instructions and report any unusual symptoms.

■ **Decentration or deviating diopter power of the lens:**

In rare cases, the implanted lens may move slightly from its position in the eye, even years after surgery. This can cause visual disturbances or glare, which can usually be corrected with a surgical procedure.

Sometimes the lens power may not perfectly match the eye, which can affect vision. This may happen if the lens does not settle exactly as predicted or due to small calculation differences. In most cases, the effect is minor. If the difference is larger, it can usually be corrected with glasses, contact lens, laser or surgery.

Inform your doctor if you experience:

- a strong pain in your eye
- recurring redness of the eye
- unusual headache or nausea
- considerable vision disturbance
- light flashes, or huge increase of floaters in your eye

These are rare complications that may occur shortly after surgery.

■ **Infections and minor complications**

As with any surgery, there is a small risk of infection after cataract surgery, although serious complications are rare. If an infection occurs, it can usually be treated with prescribed eye drops. You should contact your ophthalmologist if your eye becomes swollen or if you notice any unusual symptoms.

Some minor complications may include:

- Swelling
- Increased pressure in the eye
- Droopy eyelid

These conditions are usually temporary and improve with medication and proper healing. Inform your ophthalmologist immediately if you notice any changes so your recovery can be monitored and treated if needed.

■ **Posterior capsule opacification**

Posterior capsule opacification (PCO) is a common condition that may occur after cataract surgery. It happens when some remaining lens cells grow on the thin membrane behind the implanted lens, causing vision to become cloudy again. Although it is sometimes called a "secondary cataract," it is not a new cataract.

PCO can be easily treated with a quick and painless Nd-YAG laser procedure performed by your ophthalmologist. The treatment usually takes only a few minutes, and most patients notice improved vision within a day. If your vision becomes blurry again after surgery, contact your ophthalmologist for further advice.

Magnetic Resonance Compatibility:

The implanted IOL does not contain any metallic components and are safe with no potential for interaction with the Magnetic Resonance (MR) Field. IOL is safer for Magnet Resonance Imaging (MRI) at a magnetic field strength of 1.5 and 3.0 Tesla.

Expected lifetime and necessary follow-up

The IOL will usually last for a patient's lifetime. Should you however encounter any deterioration in your vision quality, please consult your eye doctor for further investigation and treatment. Your eye doctor will discuss with you about the necessary follow-up intervals based on your medical condition.

Reporting of serious incidents

Any serious incident that occurs in relation to the intraocular lens should be reported to your doctor (in the first instance), to the local representative or to the CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED.

About this document:

Your ophthalmologist has performed the cataract surgery and implanted the intraocular lenses (IOL) in your eye. The patient implant card and leaflet have been given to you after the cataract surgery. Please always carry the patient implant card with you to facilitate medical care in case of emergency. The link provided on the implant card will provide you latest updates about the IOL.



Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2020/000163



2460



Manufactured by:
CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED

Block No.: 310/CCE, Village Dabhaha, Taluka - Padra, Dist. Vadodra - 391 440, Gujarat, India.
Tel Free No: 1800 120 3688
customercare@cargroupsol.com
www.caregroupsol.com



European Representative



OBELIS S.A

Bel. General Wahls, 53
1030 Brussels, Belgium
Tel.: +32.2.732.59.54
Fax: +32.2.732.60.03
Email: mail@obelis.net
Web: www.obelis.net



Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2020/000163



2460



Manufactured by:
CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED

Block No.: 310/CCE, Village Dabhaha, Taluka - Padra, Dist. Vadodra - 391 440, Gujarat, India.
Tel Free No: 1800 120 3688
customercare@cargroupsol.com
www.caregroupsol.com



European Representative



OBELIS S.A

Bel. General Wahls, 53
1030 Brussels, Belgium
Tel.: +32.2.732.59.54
Fax: +32.2.732.60.03
Email: mail@obelis.net
Web: www.obelis.net

fr

À quel s'attendre pendant la chirurgie de la cataracte

La chirurgie de la cataracte est généralement réalisée en ambulatoire. Une anesthésie sous forme de gouttes ophtalmiques vous sera administrée afin d'insensibiliser votre œil. En règle générale, vous resterez pleinement éveillé pendant l'intervention. Vous ne devriez ressentir que peu ou pas d'inconfort. Votre ophthalmologiste utilisera un microscope afin d'obtenir une vue agrandie de votre œil. Votre cristallin naturel est situé dans une structure en forme de sac appelée capsule cristalliniennne. La capsule cristalliniennne se trouve juste derrière la partie colorée de l'œil (l'iris). Une petite incision est pratiquée à la surface externe de l'œil. L'ophthalmologiste introduit une minuscule sonde à travers cette ouverture afin de fragmenter le cristallin cataracté. Il utilise ensuite un dispositif d'aspiration pour retirer les fragments de cataracte de votre œil. Un espace est alors disponible pour l'implantation de la LIO dans votre œil, afin de remplacer le cristallin naturel que votre ophthalmologiste vient de retirer. Votre médecin introduira la LIO à travers la même petite incision. Une fois l'intervention terminée, votre ophthalmologiste pourra placer un pansement ou une coque de protection sur votre œil.

À quel s'attendre après la chirurgie de la cataracte

Immédiatement après l'intervention, vous devrez rester quelque temps dans la zone de récupération. Votre ophthalmologiste devra vous remettre une carte d'identification généralement appelée carte d'implant à conserver dans votre portefeuille. Cette carte indique le type d'implant présent dans votre œil. Présentez cette carte à tout ophthalmologiste qui examinera vos yeux après l'intervention.

De nombreux patients commencent à mieux voir dans un délai de 1 à 2 jours. Chez certains, la vision se stabilise au bout de 10 à 14 jours. D'autres peuvent nécessiter 4 à 6 semaines pour récupérer complètement après l'intervention. L'amélioration de la vision varie d'une personne à l'autre.

Contactez immédiatement votre ophthalmologiste si vous ressentez des démanègements, des douleurs, des éclairs lumineux, des « corps flottants », une rougeur, de forts maux de tête, des nausées/vomissements, une sensibilité à la lumière ou un larmoiement après l'intervention.

Instructions relatives aux soins postopératoires

Vous pourrez rentrer chez vous le jour même de l'intervention. Votre ophthalmologiste vous prescrira des collyres antibiotiques et des médicaments destinés à accélérer la cicatrisation et à prévenir les infections. Prenez tous les médicaments prescrits et appliquez les collyres conformément aux instructions de votre ophthalmologiste.

Pendant la première semaine suivant l'intervention, évitez de nager ainsi que l'utilisation d'une baignoire ou d'un bain à remous afin de prévenir les infections. Essayez également de protéger votre œil de la saleté, de la poussière et des vents forts. Gardez vos yeux protégés avec des lunettes de soleil autant que possible et portez votre coque de protection oculaire pendant la nuit. Vous devez éviter de vous frotter l'œil ou d'exercer une pression supplémentaire sur celui-ci. Une autre et une dernière visite sera communiquée pour une visite de suivi, généralement le lendemain de l'intervention. Votre médecin vous examinera plusieurs fois après l'opération en fonction de la vitesse de cicatrisation. Il peut vous falloir un certain temps pour vous habituer à votre nouvelle LIO.

Parlez à votre ophthalmologiste si vous avez des questions ou des préoccupations après l'intervention.

Effets indésirables, avertissements et risques résiduels

■ **Phénomènes lumineux résuels**

Après une chirurgie de la cataracte, certains patients peuvent remarquer des éblouissements ou des halos, particulièrement dans des conditions de faible luminosité. Les halos apparaissent sous forme d'anneaux lumineux autour des sources de lumière, tandis que l'éblouissement correspond à une lumière intense pouvant altérer la qualité de la vision. Ces effets peuvent être plus perceptibles lors de la conduite de nuit ou lors de l'observation de lumières artificielles.

Dans la plupart des cas, ces effets s'améliorent au bout de quelques semaines ou de quelques mois à mesure que le cerveau s'adapte à la lentille intraoculaire. Si ces phénomènes persistent après la période de cicatrisation, consultez votre ophthalmologiste. Suivez toujours les instructions de votre chirurgien et signalez tout symptôme inhabituel.

■ **Décentrement ou puissance dioptrique inadéquate de la lentille**

Dans de rares cas, la lentille implantée peut se déplacer légèrement de sa position dans l'œil, même plusieurs années après l'intervention. Cela peut entraîner des perturbations visuelles ou un éblouissement, qui peuvent généralement être corrigés par une intervention chirurgicale.

Il arrive parfois que la puissance de la lentille ne corresponde pas parfaitement à l'œil, ce qui peut affecter la vision. Cela peut se produire si la lentille ne se positionne pas exactement comme prévu ou en raison de légères différences de calcul. Dans la plupart des cas, l'effet est mineur. Si l'écart est plus important, il peut généralement être corrigé par des lunettes, des lentilles de contact, une intervention LASIK ou une chirurgie.

Informez votre médecin si vous présentez :

- une douleur importante dans l'œil ;
- une rougeur récurrente de l'œil ;
- des maux de tête inhabituels ou des nausées ;
- une détérioration importante de la vision ;
- des éclairs lumineux ou une augmentation importante du nombre de corps flottants dans votre œil.

Il s'agit de complications rares pouvant survenir peu après l'intervention.

■ **Infections et complications mineures**

Comme pour toute intervention chirurgicale, il existe un faible risque d'infection après une chirurgie de la cataracte, bien que les complications graves soient rares. En cas d'infection, celle-ci peut généralement être traitée à l'aide de collyres prescrits. Vous devez contacter votre ophthalmologiste si votre œil devient enflé ou si vous remarquez des symptômes inhabituels.

Certaines complications mineures peuvent inclure :

- un gonflement ;
- une augmentation de la pression intraoculaire ;
- une chute de la paupière.

Ces affections sont généralement temporaires et s'améliorent grâce aux médicaments et à une cicatrisation appropriée. Informez immédiatement votre ophthalmologiste si vous remarquez des changements afin que votre rétablissement puisse être surveillé et traité si nécessaire.

■ **Postérieur capsule opacification**

L'opacification de la capsule postérieure (OCP) est une affection fréquente qui peut survenir après une chirurgie de la cataracte. Elle se produit lorsque certaines cellules résiduelles du cristallin prolifèrent sur la fine membrane située derrière la lentille implantée, provoquant à nouveau une vision trouble. Bien qu'elle soit parfois appelée « cataracte secondaire », il ne s'agit pas d'une nouvelle cataracte.

L'OCP peut être facilement traitée par une intervention rapide et indolore au laser Nd:YAG réalisée par votre ophthalmologiste. Le traitement ne dure généralement que quelques minutes et la vision des patients constate une amélioration de leur vision dans la journée qui suit. Si votre vision redevient floue après l'intervention, contactez votre ophthalmologiste pour obtenir des conseils supplémentaires.

Compatibilité avec la résonance magnétique

La LIO implantée ne contient aucun composant métallique et ne présente aucun risque d'interaction avec le champ de résonance magnétique (RM). La LIO est compatible avec l'imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée à des intensités de champ magnétique de 1,5 et 3,0 Tesla.

Durée de vie attendue et suivi nécessaires

La LIO est généralement conçue pour durer toute la vie du patient. Toutefois, si vous constatez une détérioration de la qualité de votre vision, veuillez consulter votre ophthalmologiste afin de procéder à des examens complémentaires et à un traitement approprié. Votre ophthalmologiste discutera avec vous de la fréquence des consultations de suivi nécessaires en fonction de votre état de santé.

Déclaration des incidents graves

Tout incident grave survenant en lien avec la lentille intraoculaire doit être signalé à votre médecin (en premier lieu), au représentant local ou à CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED.

À propos de ce document :

Votre ophthalmologiste a réalisé la chirurgie de la cataracte et a implanté les lentilles intraoculaires (LIO) dans votre œil. La carte d'implant du patient ainsi que cette notice vous ont été remises après l'intervention chirurgicale de la cataracte. Veuillez toujours conserver la carte d'implant du patient sur vous afin de faciliter la prise en charge médicale en cas d'urgence. Le lien indiqué sur la carte d'implant vous permettra d'accéder aux dernières mises à jour concernant la LIO.



N° de licence de fabrication : MFG/MD/2020/000163



2460



Fabriqué par:
CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED

Block No.: 310/CCE, Village Dabhaha, Taluka - Padra, District Vadodra - 391 440, Gujarat, Inde
Numéro vert : 1800 120 3688
Email : customercare@cargroupsol.com
Site web : www.caregroupsol.com



Représentant européen



OBELIS S.A

Bel. Général Wahls, 53
1030 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32.2.732.59.54
Fax : +32.2.732.60.03
Email : mail@obelis.net
Site web : www.obelis.net

de

von einer anderen Person nach Hause gefahren werden.

Was Sie nach einer Kataraktoperation erwarten können

Eine Kataraktoperation wird in der Regel ambulant durchgeführt. Sie erhalten ein Betäubungsmittel in Form von Augentropfen, um Ihr Auge zu betäuben. Normalerweise bleiben Sie während des Eingriffs vollständig wach. Sie sollten nur geringe oder keine Beschwerden verspüren. Ihr Augenarzt verwendet ein Mikroskop, um Ihr Auge vergrößert betrachten zu können. Ihre natürliche Linse befindet sich in einer sackartigen Struktur, die als Linsen-kapsel bezeichnet wird. Die Linsen-kapsel befindet sich direkt hinter dem farbigen Teil Ihres Auges (Iris). An der äußeren Oberfläche des Auges wird ein kleiner Schnitt vorgenommen. Durch diese Öffnung führt der Augenarzt eine winzige Sonde ein, um die eingebrütete Linse zu zerkleinern. Anschließend werden die Kataraktfragmente mit einem kleinen vakuumähnlichen Instrument aus dem Auge entfernt. Danach steht ausreichend Platz zur Verfügung, um die Intraokularlinse in Ihr Auge einzusetzen und die zuvor entfernte natürliche Linse zu ersetzen. Ihr Arzt setzt die Intraokularlinse durch denselben kleinen Schnitt ein. Nach Abschluss der Operation kann Ihr Augenarzt einen schützenden Verband oder eine Schutzschale über Ihr Auge legen.

Was Sie nach einer Kataraktoperation erwarten können

Unmittelbar nach der Operation sollten Sie für kurze Zeit im Aufwachbereich bleiben. Ihr Augenarzt sollte Ihnen eine Identifikationskarte (üblicherweise Implantationskarte genannt) aushändigen, die Sie in Ihrer Briefschale aufbewahren sollten. Diese Karte enthält Angaben zum Typ des in Ihrem Auge eingesetzten Implantats. Zeigen Sie diese Karte jedem Augenarzt vor, der Ihre Augen nach der Operation untersucht.

Viele Patienten bemerken bereits innerhalb von 1 bis 2 Tagen eine Verbesserung ihres Sehvermögens. Bei einigen stabilisiert sich das Sehvermögen nach 10 bis 14 Tagen. Andere benötigen 4 bis 6 Wochen, um sich vollständig von der Operation zu erholen. Die Verbesserung des Sehvermögens ist von Person zu Person unterschiedlich.

Wenden Sie sich sofort an Ihren Augenarzt, wenn nach der Operation Kopfschmerzen, Schmerzen, Lichtblitze, "fliegende Mücken" (Floaters), Rötungen, starke Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Lichtempfindlichkeit oder tränende Augen auftreten.

Anweisungen zur postoperativen Nachsorge

Sie können am selben Tag nach der Operation nach Hause zurückkehren. Ihr Augenarzt wird Ihnen antibiotische Augentropfen und Medikamente verschreiben, um die Heilung zu beschleunigen und Infektionen vorzubeugen. Nehmen Sie alle verordneten Medikamente ein und wenden Sie die Augenoperation gemäß den Anweisungen Ihres Augenarztes an.

Vermeiden Sie in der ersten Woche nach der Operation das Schwimmen sowie die Benutzung von Badewannen oder Whirlpools, um Infektionen vorzubeugen. Versuchen Sie außerdem, Ihr Auge vor Schmutz, Staub und starken Wind zu schützen. Tragen Sie möglichst häufig eine Sonnenbrille zum Schutz Ihrer Augen und verwenden Sie nachts die Augenschutzschale. Vermeiden Sie es, Ihr Auge zu reiben oder zusätzlichen Druck darauf auszuüben. Sie erhalten einen Termin für eine Nachuntersuchung, die in der Regel am nächsten Tag stattfindet. Je nach Heilungsverlauf wird Ihr Arzt Ihre Augen nach der Operation noch mehrere Male untersuchen. Es kann einige Zeit dauern, bis Sie sich an die neue Intraokularlinse gewöhnt haben.

Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt, wenn Sie nach der Operation Fragen oder Bedenken haben.

Un erwünschte Nebenwirkungen, Warnhinweise und Restrisiken

Visuelle Lichtphänomene

Nach einer Kataraktoperation können einige Patienten Blendungen oder Halos bemerken, insbesondere bei schwachen Lichtverhältnissen. Halos erscheinen als helle Ringe um Lichtquellen, während Blendungen als starkes Licht wahrgenommen werden, das die klare Sehen beeinträchtigen kann. Diese Effekte können besonders beim nächtlichen Autofahren oder beim Blick auf künstliche Lichtquellen auftreten.

In den meisten Fällen verbessern sich diese Erscheinungen innerhalb weniger Wochen oder Monate, während sich das Gehirn an die Intraokularlinse anpasst. Sollten die Symptome nach Abschluss der Heilungsphase weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Augenarzt. Befolgen Sie stets die Anweisungen Ihres Chirurgen und melden Sie ungewöhnliche Symptome.

■ **Dezentrierung oder abweichende Dioptrienstärke der Linse**

In seltenen Fällen kann sich die implantierte Linse auch Jahre nach der Opeation geringfügig aus ihrer Position im Auge verschieben. Dies kann Sehstörungen oder Blendungen verursachen, die in der Regel durch einen chirurgischen Eingriff korrigiert werden können.

Manchmal entspricht die Linsenstärke nicht exakt den Anforderungen des Auges, was das Sehvermögen beeinträchtigen kann. Dies kann auftreten, wenn sich die Linse nicht genau wie vorhergesehen positioniert oder aufgrund kleiner Berechnungsabweichungen. In den meisten Fällen ist die Auswirkung gering. Bei größeren Abweichungen kann die Fehlsichtigkeit normalerweise mit einer Brille, Kontaktlinsen, LASIK oder einem chirurgischen Eingriff korrigiert werden.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn bei Ihnen Folgendes auftritt :

- starke Schmerzen im Auge
- wiederkehrende Augenrötungen
- ungewöhnliche Kopfschmerzen oder Übelkeit
- erhebliche Verschlechterung des Sehvermögens
- Lichtblitze oder eine starke Zunahme von „fliegenden Mücken“ (Floaters) im Auge

Dies sind seltene Komplikationen, die kurz nach der Operation auftreten können.

■ **Infectionen und geringfügige Komplikationen**

Wie bei jeder Operation besteht auch nach einer Kataraktoperation ein geringes Infektionsrisiko, obwohl schwerwiegende Komplikationen selten sind. Tritt eine Infektion auf, kann sie in der Regel mit verschriebenen Augentropfen behandelt werden. Sie sollten Ihren Augenarzt kontaktieren, wenn Ihr Auge anschwillt oder wenn Sie ungewöhnliche Symptome bemerken.

Zu den geringfügigen Komplikationen können gehören :

- Schwellungen
- Erhöhter Augeninnendruck
- Herabhängendes Augenlid

Diese Zustände sind in der Regel vorübergehend und bessern sich durch Medikamente und einen normalen Heilungsverlauf. Informieren Sie Ihren Augenarzt unverzüglich, wenn Sie Veränderungen bemerken, damit Ihre Genesung überwacht und gegebenenfalls behandelt werden kann.

■ **Nachstar (Posterior Capsule Opacification, PCO)**

Der Nachstar (Posterior Capsule Opacification, PCO) ist eine häufige Erscheinung, die nach einer Kataraktoperation auftreten kann. Er entsteht, wenn verbliebene Linsenzellen auf der dünnen Membran hinter der implantierten Linse wachsen und dadurch das Sehvermögen erneut trüben. Obwohl dies manchmal als „sekundärer Katarakt“ bezeichnet wird, handelt es sich nicht um einen neuen Katarakt.

PCO kann einfach durch einen schnellen und schmerzfreien Nd:YAG-Lasereingriff behandelt werden, der von Ihrem Augenarzt durchgeführt wird. Die Behandlung dauert nur wenige Minuten, und die meisten Patienten bemerken innerhalb eines Tages eine Verbesserung ihres Sehvermögens. Wenn Ihr Sehvermögen nach der Operation erneut verschwommen wird, wenden Sie sich für weitere Beratung an Ihren Augenarzt.

Magnetresonanz-Kompatibilität

Die implantierte Intraokularlinse enthält keine metallischen Bestandteile und ist sicher, da kein Risiko einer Wechselwirkung mit dem Magnetresonanzenfeld (MR-Feld) besteht. Die Intraokularlinse ist für Magnetresonanztomographie (MRT) bei Magnetfeldstärken von 1,5 Tesla und 3,0 Tesla geeignet.

Erwartete Lebensdauer und erforderliche Nachsorge

Die Intraokularlinse hält in der Regel ein Leben lang. Sollten Sie jedoch eine Verschlechterung ihrer Sehqualität feststellen, wenden Sie sich bitte zur weiteren Untersuchung und Behandlung an Ihren Augenarzt. Ihr Augenarzt wird mit Ihnen die erforderlichen Nachsorgeintervalle entsprechend Ihrem Gesundheitszustand besprechen.

Meldung schwerwiegender Vorkommnisse

Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit der Intraokularlinse sollte Ihrem Arzt (zunächst), dem örtlichen Vertreter oder CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED gemeldet werden.

Über dieses Dokument

Ihr Augenarzt hat die Kataraktoperation durchgeführt und die Intraokularlinse (IOL) in Ihr Auge implantiert. Die Patienten-Implantationskarte und dieses Informationsblatt wurden Ihnen nach der Kataraktoperation ausgehändigt. Bitte führen Sie die Patienten-Implantationskarte stets mit sich, um im Notfall eine angemessene medizinische Versorgung zu erleichtern. Über den auf der Implantationskarte angegebenen Link erhalten Sie die neuesten Informationen zur Intraokularlinse.



Licenza di produzione n.º: MFG/MD/2020/000163



2460



Prodotto da:
CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED

Block No.: 310/CCE, Dorf Dabhaha, Taluka - Padra, Distretto Vadodra - 391 440, Gujarat, India.
Numero verde: 1800 120 3688
Email: customercare@cargroupsol.com
Sito web: www.caregroupsol.com



Representante Europeo



OBELIS S.A

Bel. Général Wahls, 53
1030 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32.2.732.59.54
Fax : +32.2.732.59.54
Email: mail@obelis.net
Web: www.obelis.net

it

Successivamente, utilizza un piccolo dispositivo simile a un aspiratore per rimuovere i frammenti di cataratta dall'occhio. A questo punto si crea lo spazio necessario per inserire la IOL nell'occhio e sostituire il cristallino naturale appena rimosso. Il medico inserirà la IOL attraverso la stessa piccola incisione. Al termine dell'intervento, l'oculista può applicare una medicazione protettiva o una scopa protettivo sull'occhio.

Cosa aspettarsi dopo l'intervento di cataratta

Subito dopo l'intervento, dovreste rimanere nell'area di recupero per un breve periodo. Il vostro oculista dovrebbe consegnarvi una scheda identificativa (generalmente chiamata scheda aspiratore) da conservare nel portafoglio. Questa scheda indica il tipo di impianto presente nel vostro occhio. Mostrare questa scheda a qualsiasi oculista che esamini i vostri occhi dopo l'intervento.

Molti pazienti iniziano a vedere meglio entro 1 o 2 giorni. In alcuni casi la vista si stabilizza entro 10-14 giorni. Altri pazienti possono impiegare da 4 a 6 settimane per recuperare completamente dall'intervento. Il miglioramento della vista varia da persona a persona.

Contattate immediatamente il vostro oculista se dopo l'intervento avvertite prurito, dolore, lampi di luce, "corpi mobili" (floaters), arrossamento, forte mal di testa, nausea/vomito, sensibilità alla luce o lacrimazione eccessiva.

Istruzioni per le cure post-operatorie

Potrete tornare a casa lo stesso giorno dell'intervento. Il vostro oculista vi prescriverà collyri antibiotici e farmaci per accelerare la guarigione e prevenire le infezioni. Assumete tutti i farmaci prescritti e applicateli i colliri secondo le indicazioni del vostro oculista.

Durante la prima settimana dopo l'intervento, evitate di nuotare e di utilizzare vasche da bagno o idromassaggio per contribuire a prevenire le infezioni. Cercate inoltre di proteggere l'occhio da sporco, polvere e vento forte. Protegetevi gli occhi il più possibile con occhiali da sole e dormite con la protezione oculare durante la notte. Evitate di strofinare l'occhio o di esercitare pressione su di esso. Vi verrà fissata una visita di controllo, generalmente il giorno successivo all'intervento. Il medico vi visiterà più volte dopo l'operazione in base alla velocità di guarigione. Potrebbe essere necessario un po' di tempo per abituarsi alla nuova IOL.

Parlate con il vostro oculista se avete domande o dubbi dopo l'intervento.

Effetti indesiderati, avvertenze e rischi residui

Fenomeni luminosi visivi

Dopo l'intervento di cataratta, alcuni pazienti possono notare abbagliamento o aloni, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Gli aloni appaiono come anelli luminosi attorno alle fonti di luce, mentre l'abbagliamento si manifesta come una luce intensa che può compromettere la visione nitida. Questi effetti possono essere più evidenti durante la guida notturna o osservando luci artificiali.

Nella maggior parte dei casi, tali effetti migliorano entro poche settimane o mesi, man mano che il cervello si adatta alla lente intraoculare. Se persistono dopo la guarigione, consultate il vostro oculista. Seguite sempre le istruzioni del chirurgo e segnalate qualsiasi sintomo insolito.

Decentramento o potere diottrico non corretto della lente

In rari casi, la lente implantata può spostarsi leggermente dalla sua posizione all'interno dell'occhio, anche anni dopo l'intervento. Questo può causare disturbi visivi o abbagliamento, che generalmente possono essere corretti mediante una procedura chirurgica.

A volte il potere della lente potrebbe non corrispondere perfettamente all'occhio, il che può compromettere la visione. Ciò può accadere se la lente non si posiziona esattamente come previsto o a causa di piccole differenze nei calcoli. Nella maggior parte dei casi, l'effetto è minimo. Se la differenza è maggiore, può generalmente essere corretta con occhiali, lenti a contatto, LASIK o un intervento chirurgico.

Informate il vostro medico se manifestate :

- forte dolore all'occhio
- arrossamento ricorrente dell'occhio
- mal di testa insolito o nausea
- notevole peggioramento della vista
- lampi di luce o un marcato aumento dei corpi mobili (floaters) nell'occhio

Queste sono complicanze rare che possono verificarsi poco dopo l'intervento chirurgico.

Infezioni e complicanze minori

Come per qualsiasi intervento chirurgico, esiste un piccolo rischio di infezione dopo l'intervento di cataratta, sebbene le complicanze gravi siano rare. Se si verifica un'infezione, di solito può essere trattata con colliri prescritti dal medico. Dovreste contattare il vostro oculista se l'occhio si gonfia o se notate sintomi insoliti.

Alcune complicanze minori possono includere :

- Gonfiore
- Aumento della pressione intraoculare
- Abbassamento della palpebra

Queste condizioni sono generalmente temporanee e migliorano con la terapia farmacologica e una corretta guarigione. Informate immediatamente il vostro oculista se notate qualsiasi cambiamento, in modo che il recupero possa essere monitorato e trattato se necessario.

Opacizzazione della capsula posteriore

L'opacizzazione della capsula posteriore (OCP) è una condizione comune che può verificarsi dopo l'intervento di cataratta. Si verifica quando alcune cellule residue del cristallino crescono sulla sottile membrana situata dietro la lente implantata, causando nuovamente un annebbiamento della vista. Sebbene venga talvolta chiamata "cataratta secondaria", non si tratta di una nuova cataratta.

La PCO può essere facilmente trattata mediante una procedura laser Nd-YAG rapida e indolore eseguita dal vostro oculista. Il trattamento richiede generalmente solo pochi minuti e la maggior parte dei pazienti nota un miglioramento della vista entro un giorno. Se la vostra vista torna ad essere sfocata dopo l'intervento, contattate il vostro oculista per ulteriori consigli.

Compatibilità con la Risonanza Magnetica

La IOL implantata non contiene componenti metallici ed è sicura, senza alcun potenziale di interazione con il campo di Risonanza Magnetica (RM). La IOL è sicura per l'esecuzione di esami di Risonanza Magnetica per Immagini (MRI) con intensità del campo magnetico di 1,5 Tesla e 3,0 Tesla.

Durata prevista e follow-up necessari

La IOL generalmente dura per tutta la vita del paziente. Tuttavia, qualora dovste riscontrare un peggioramento della qualità della vista, consultate il vostro oculista per ulteriori accertamenti e trattamenti. Il vostro oculista discuterà con voi la frequenza dei controlli necessari in base alle vostre condizioni cliniche.

Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione alla lente intraoculare deve essere segnalato al proprio medico (in prima istanza), al rappresentante locale o a CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED.

Informazioni su questo documento

Il vostro oculista ha eseguito l'intervento di cataratta e ha implantato la lente intraoculare (IOL) nel vostro occhio. La scheda impianto del paziente e questo foglio informativo vi sono stati consegnati dopo l'intervento di cataratta. Vi invitiamo a portare sempre con voi la scheda impianto del paziente per facilitare l'assistenza medica in caso di emergenza. Il collegamento riportato sulla scheda impianto vi fornirà gli aggiornamenti più recenti relativi alla IOL.



Licenza di produzione n.º: MFG/MD/2020/000163



2460



Prodotto da:
CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED

Block No.: 310/CCE, Dorf Dabhaha, Taluka - Padra, Distretto Vadodra - 391 440, Gujarat, India.
Numero verde: 1800 120 3688
Email: customercare@cargroupsol.com
Sito web: www.caregroupsol.com



Representante Europeo



OBELIS S.A

Bel. Général Wahls, 53
1030 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32.2.732.59.54
Fax : +32.2.732.59.54
Email: mail@obelis.net
Web: www.obelis.net

pt

uma pequena sonda através desta abertura para fragmentar o cristalino afetado por a catarata. Em seguida, utiliza um pequeno dispositivo semelhante a um aspirador para retirar os fragmentos de catarata do olho. Então espaço disponível para colocar a LIO no olho, substituindo o cristalino natural que acabou de ser removido. O médico introduzirá a LIO através da mesma pequena incisão. Quando a cirurgia estiver concluída, o oftalmologista poderá colocar um penso ou escudo protetor sobre o olho.

O que esperar após a cirurgia às cataratas

Imediatamente após a cirurgia, deverá permanecer durante um curto período na área de recuperação. O seu oftalmologista deverá entregar-lhe um cartão de identificação (normalmente denominado cartão de implante) para guardar na carteira. Este cartão indica o tipo de implante que tem no seu olho. Apresente este cartão a qualquer oftalmologista que examine os seus olhos após a cirurgia.

Muitos pacientes começam a ver melhor no prazo de 1 a 2 dias. Alguns estabilizam entre 10 a 14 dias. Outros podem demorar entre 4 e 6 semanas a recuperar da cirurgia. A melhoria da visão varia de pessoa para pessoa.

Contacte imediatamente o seu oftalmologista se sentir comichão, dor, flashes de luz, "moscas volantes", vermelhidão, dor de cabeça intensa, náuseas/vômitos, sensibilidade à luz ou lacrimejo após a cirurgia.

Instruções para os cuidados pós-operatórios

Podrá regressar a casa no próprio dia da cirurgia. O seu oftalmologista prescreverá colírios oftálmicos antibióticos e medicamentos para acelerar a cicatrização e prevenir infeções. Tome todos os medicamentos prescritos e aplique as gotas oftálmicas de acordo com as instruções do seu oftalmologista.

Durante a primeira semana após a cirurgia, não nade nem utilize banheiras ou jacuzzis para ajudar a prevenir infeções. Tente também proteger o olho de sujidade, pó e vento forte. Mantenha os olhos protegidos com óculos de sol sempre que estiver ao ar livre. Evite esfregar o olho ou exercer pressão adicional sobre ele. Se lhe é marcada uma consulta de acompanhamento com data e hora definidas. Normalmente, esta ocorre no dia seguinte. O seu médico irá examiná-lo várias vezes após a cirurgia, dependendo da velocidade da cicatrização. Poderá demorar algum tempo até se habituar à nova LIO.

Fale com o seu oftalmologista se tiver quaisquer dúvidas ou preocupações após a cirurgia.

Effeitos secundários indesejáveis, advertências e riscos residuais

Fenómenos visuais relacionados com a luz

Após a cirurgia às cataratas, alguns pacientes podem notar encandecimento ou halos, especialmente em condições de pouca luz. Os halos aparecem como anéis luminosos em redor das luzes, enquanto o encandecimento corresponde a luz intensa que pode afetar a nitidez da visão. Estes efeitos podem ser mais perceptíveis durante a condução noturna ou ao observar luzes artificiais.

Na maioria dos casos, estes efeitos melhoram ao longo de algumas semanas ou meses, à medida que o cérebro se adapta à lente intraocular. Se persistirem após a cicatrização, consulte o seu oftalmologista. Siga sempre as instruções do seu cirurgião e comunique quaisquer sintomas invulgares.

Descentração ou potência dióptrica divergente da lente

Em casos raros, a lente implantada pode deslocar-se ligeiramente da sua posição no olho, mesmo anos depois da cirurgia. Isto pode causar perturbações visuais ou encandecimento, que normalmente podem ser corrigidas através de um procedimento cirúrgico.

Por vezes, a potência da lente não pode corresponder perfeitamente ao olho, o que pode afetar a visão. Isto pode acontecer se a lente não se posicionar exatamente como previsto ou devido a pequenas diferenças nos cálculos. Na maioria dos casos, o efeito é reduzido. Se a diferença for maior, geralmente pode ser corrigida com óculos, lentes de contacto, LASIK ou cirurgia.

Informe o seu médico se sentir :

- dor intensa no olho
- vermelhidão recorrente do olho
- dor de cabeça invulgar ou náuseas
- deterioração significativa da visão
- flashes de luz ou aumento acentuado do número de moscas volantes no olho

Estas são complicações raras que podem ocorrer pouco tempo após a cirurgia.

Infeções e complicações menores

Tanto acontece com qualquer cirurgia, existe um pequeno risco de infeção depois a cirurgia às cataratas, embora as complicações graves sejam raras. Se ocorrer uma infeção, esta pode normalmente ser tratada com gotas oftálmicas prescritas. Deve contactar o seu oftalmologista se o seu olho ficar inchado ou se notar quaisquer sintomas invulgares.

Algumas complicações menores podem incluir :

- Inchado
- Aumento da pressão intraocular
- Pálpebra caída

Estas condições são geralmente temporárias e melhoram com medicação e uma cicatrização adequada. Informe imediatamente o seu oftalmologista se notar quaisquer alterações para que a sua recuperação possa ser monitorizada e tratada, se necessário.

Opacificação da cápsula posterior

A opacificação da cápsula posterior (OCP) é uma condição comum que pode ocorrer após a cirurgia às cataratas. Acontece quando algumas células remanescentes do cristallino crescem sobre a fina membrana localizada atrás da lente implantada, fazendo com que a visão volte a ficar turva. Embora por vezes seja chamada de "catarata secundária", não se trata de uma nova catarata.

A PCO pode ser facilmente tratada através de um procedimento rápido e indolor com laser Nd:YAG realizado pelo seu oftalmologista. O tratamento normalmente demora apenas alguns minutos e a maioria dos pacientes nota uma melhoria da visão no espaço de um dia. Se a sua visão voltar a ficar desfocada após a cirurgia, contacte o seu oftalmologista para obter aconselhamento adicional.

Compatibilidade com Ressonância Magnética:

A LIO implantada não contém quaisquer componentes metálicos e é segura, não apresentando potencial de interação com o campo de Ressonância Magnética (RM). A LIO é segura para Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM) com intensidades de campo magnético de 1,5 e 3,0 Tesla.

Vida útil esperada e acompanhamento necessário

A LIO durará normalmente toda a vida do paciente. No entanto, caso observe qualquer deterioração da qualidade da sua visão, consulte o seu oftalmologista para investigação e tratamento adicionais. O seu oftalmologista discutirá consigo os intervalos de acompanhamento necessários com base na sua condição médica.

Notificação de incidentes graves

Qualquer incidente grave que ocorra em relação à lente intraocular deve ser comunicado ao seu médico (em primeira instância), ao representante local o a CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED.

Sobre este documento:

O seu oftalmologista realizou a cirurgia às cataratas e implantou as lentes intraoculares (LIO) no seu olho. O cartão de identificação do paciente e este folheto foram-lhe entregues após a cirurgia às cataratas. Por favor, transporte sempre consigo o cartão de identificação do paciente para facilitar os cuidados médicos em caso de emergência. A ligação fornecida no cartão de implante permitirá-lhe aceder às atualizações mais recentes sobre a LIO.



Licença de Fabricação n.º: MFG/MD/2020/000163



2460



Fabricado por:
CAREGROUP SIGHT SOLUTION PRIVATE LIMITED

Bloque N.º: 310/CCE, Vila Dabhaha, Taluka - Padra, Distrito Vadodra - 391 440, Gujarat, Índia
Número gratuito: 1800 120 3688
Fax: +32.2.732.60.03
Correio eletrónico: customercare@cargroupsol.com
Sítio web: www.caregroupsol.com



Representante Europeo



OBELIS S.A

Bel. General Wahls, 53
1030 Bruxelles, Bélgica
Tel.: +32.2.732.59.54
Fax: +32.2.732.60.03
Email: mail@obelis.net
Web: www.obelis.net

es

sonda a través de esta abertura para fragmentar el cristalino afectado por la catarata. A continuación, utiliza un pequeño dispositivo similar a un aspiradora para retirar los fragmentos de catarata del ojo. Entonces quedará espacio para colocar la LIO en el ojo y sustituir el cristalino natural que acaba de extraerse. Su médico implantará la LIO a través de la misma pequeña incisión. Cuando la cirugía haya finalizado, su oftalmólogo podrá colocar un parche o protector ocular sobre el ojo.

Que esperar después de la cirugía de cataratas

Inmediatamente después de la cirugía, deberá permanecer en la zona de recuperación durante un corto período de tiempo. Su oftalmólogo deberá entregarte una tarjeta de identificación (normalmente denominada tarjeta de implante) para que la conserve en su cartera. Esta tarjeta muestra el tipo de implante que tiene en el ojo. Presente esta tarjeta a cualquier oftalmólogo que examine sus ojos después de la cirugía.

Muchos pacientes pueden